# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 80167
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-06 10:52:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : LORENZO ENRIQUE INOSTROZA INOSTROZA | | | RUN | : 6.164.636-1 |
| F.Nac | : 10-08-1946 | Edad | : 77 AÑOS, 6 MESES | Género | : Masculino |
| Dirección | : | | | Comuna | : SAN NICOLAS |
| Previsión | : SIN INFORMACION | Teléfono | : 0 | | |
| Fecha Ingreso | : 2024-03-05 | Fecha Egreso | : 2024-03-06 10:52:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SD FEBRIL , OBS FOCO RESPIRATORIO
NEUMONIA (NAC) ATS 3
AM: HTA; DM2 IR; ERC en HD (desde hace 4 años), PIE DIABETICO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente derivado desde APS secundario a compromiso del estado general sobre basal. Funcionalidad previa limitada. Destaca además aumento de temperatura no cuantificado (tampoco dentro de atención de urgencias), con cambio de coloración y olor de orina. Destaca además, pie diabético izquierdo con herida ulcerosa valorada por CX quien descarta manejo.
Previamente el 29/02 valorado por CX (Dr. Zugbe) quien refiere que ulceración en pie izquierdo tiene características infecciosas. Se indica Ceftriaxona 2gr ev día los cuales el paciente no cumple a cabalidad (se administran sólo dos días de tratamiento según atenciones en APS, secundario a conducta del mismo, además de su franco deseo de no continuar colocándoselo).
Se toman exámenes de laboratorio de ingreso dentro de lo que destaca:
Glicemia: 279 mg/dl | Creatinina: 9,00 mg/dl | Ácido Úrico: 4,70 mg/dL | Calcio: 9,1 mg/dL | Fosfatasa Alcalina: 89 U/L | LDH: 170 U/L | Clearence Calculado(MDRD): 5,63 ml/min/1,73 | Lactato: 0,8 mmol/L | Triglicéridos: 202 mg/dL | Proteína C Reactiva: 187,6 mg/L | Nitrógeno Ureico: 53 mg/dL | Uremia: 114 mg/dl | Sodio (Na): 133,00 mmol/L | Potasio (K): 4,40 mmol/L | Cloro (Cl): 93,00 mmol/L | Hemoglobina: 10,3 g/dl | Hematocrito: 30,3 o/o | Recuento de leucocitos: 10,00 mil/ul |
Se rescata cultivo de herida oct 2023 que reporta S. agalactiae (¿) polisensible.
En vista de condiciones y antecedentes se decide ingreso a servicio.

Paciente en sala relativas buenas condiciones generales
Hdn estable, afebril, sin requerimiento de o2, refiere dolor dorsolumbar que persiste, pero disminuye con aines
Llaman familiares avisando que lo fueron a buscar a domicilio de centro de dialisis, familiares no informaron que se ingreso, o no se pudieron contactar (numero de centro no tiene telefono)
Se llama a Dra del centro de dialisis Montahue, (Dra Mouriño) refiere que estando hospitalizado no reciben pacientes, ademas que tendria una osteomielitis o proceso infeccioso que no le permitiria acudir por eventual decompensacion, y que sea dirigido a dialisis en hchm.
Se revisan muchos DAUs de atenciones en urgencia y no se establece en ninguno dgco de osteomielitis. (si negativa de pcte de seguir indicaciones ya sea de tto atb o sugerencias de amputacion eii)
Al exam rr2t, mp+, sin ruidos agregados. Bd b d i, amputacion ic eid y ortejos de pie derecho (tmt) con lesion activa lateral del pie, pero sin exudado

PACIENTE BCG, AFEBRIL, SIN REQUERIMIENTO DE O2, HDN ESTABLE, COMPLETANDO TTO ATB, CON DESCENSO DE PARÁMETROS INFLAMATORIOS. POR ELLO SE DECIDE ENVIAR A HODOM.

## PLAN DE MANEJO:

A HODOM PARA CONTINUAR TTO ATB (RESCATAR HC)
RETOMAR CICLO DE HD DESDE DOMICILIO EL JUEVES (SE AVISA A DRA MOURIÑO CENTRO DIALISIS MONTAHUE)

## INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO, ASISTIDO
2. REGIMEN HIPOSODICO DIABETICO
3. CURACIONES POR ENFERMERIA DIA POR MEDIO
4. INS NPH 26 U AM - 12 U PM SC (O SEGUN ESQUEMA PREVIO DE DOMICILIO)
5. RESCATAR HC / CULTIVO TEJIDO
6. CEFTRIAXONA 2 GR AL DIA EV (COMPLETAR 7 DIAS)
7. PARACETAMOL 500MG 2 C/8HRS VO
8. METAMIZOL 300MG 1 C/8HRS SOS SI MAS DOLOR VO
9. OMEPRAZOL 20MG 1 AL DIA VO
10. AMLODIPINO 10MG ½ AL DIA VO
11. RETOMAR TRATAMIENTOS Y CONTROLES CRONICOS (INSULINA Y OTROS)

## EXÁMENES Y RESULTADOS

TC de TX CC que reporta (04/03):
El segmento apical del lóbulo inferior derecho se evidencia área de aumento de atenuación en vidrio esmerilado con una morfología pseudonodular y en íntimo contacto con la cisura mayor en probable relación con proceso inflamatorio/infeccioso en evolución. Adyacente al mismo se observa adenomegalia de aproximadamente 14. 5 mm.
PieloTC que reporta (04/03):
Ausencia de litiasis renales en tránsito o signos de uronefrosis.

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO